

LA PSYCHOLOGIE HUMAINE

Fondements théoriques et principales pathologies associées

Document de synthèse — Septembre 2026

1. Introduction à la psychologie humaine

La psychologie est la discipline scientifique qui étudie les processus mentaux, les comportements et les expériences subjectives de l'être humain. Elle cherche à comprendre comment les individus perçoivent le monde, traitent l'information, ressentent des émotions, prennent des décisions et interagissent avec leur environnement social. Contrairement à une idée répandue, la psychologie ne se limite pas à l'étude des troubles mentaux : elle couvre un champ beaucoup plus vaste, allant du fonctionnement cognitif normal au développement de l'enfant, en passant par la psychologie sociale, la psychologie du travail ou encore la neuropsychologie.

En tant que science, la psychologie s'appuie sur des méthodes empiriques : observation, expérimentation, études de cas et outils statistiques. Elle se distingue ainsi des approches purement philosophiques ou introspectives qui l'ont précédée historiquement. La psychologie moderne est généralement considérée comme née à la fin du XIXe siècle, avec la création du premier laboratoire de psychologie expérimentale par Wilhelm Wundt à Leipzig en 1879.

Ce document propose un panorama des grands courants théoriques qui ont structuré la discipline, des processus psychologiques fondamentaux, puis des principales pathologies psychologiques reconnues à ce jour, avant d'aborder brièvement les approches thérapeutiques existantes.

Sur le plan méthodologique, la psychologie combine aujourd'hui plusieurs approches complémentaires : les études expérimentales en laboratoire, qui permettent d'isoler des variables précises dans des conditions contrôlées ; les études de terrain et les enquêtes à grande échelle, qui offrent une meilleure validité écologique ; ainsi que les études longitudinales, qui suivent les mêmes individus sur de longues périodes pour observer l'évolution de certains phénomènes psychologiques au fil du temps. Chacune de ces méthodes présente des avantages et des limites propres, ce qui explique pourquoi la convergence de plusieurs types d'études est généralement recherchée avant qu'une conclusion scientifique ne soit considérée comme solidement établie.

2. Les grands courants théoriques de la psychologie

2.1 Le behaviorisme (comportementalisme)

Développé au début du XXe siècle par des chercheurs comme John Watson puis B.F. Skinner, le behaviorisme postule que seuls les comportements observables méritent d'être étudiés scientifiquement, à l'exclusion des états mentaux internes jugés inaccessibles à l'observation directe. Cette approche a mis en évidence les mécanismes de conditionnement (classique et opérant) qui expliquent comment un comportement peut être appris, renforcé ou éteint en fonction de ses conséquences.

2.2 La psychanalyse

Fondée par Sigmund Freud à la fin du XIXe siècle, la psychanalyse postule l'existence de processus inconscients qui influencent la pensée et le comportement, souvent en lien avec des conflits internes ou des expériences précoces de l'enfance. Bien que largement critiquée aujourd'hui sur le plan de sa validité scientifique stricte, elle a durablement marqué la culture occidentale et influencé de nombreuses approches thérapeutiques ultérieures, notamment les thérapies psychodynamiques.

2.3 Le cognitivisme

Apparu dans les années 1950-1960 en réaction aux limites du behaviorisme, le cognitivisme s'intéresse aux processus mentaux internes : mémoire, attention, langage, raisonnement, résolution de problèmes. Il compare souvent le fonctionnement de l'esprit à celui d'un système de traitement de l'information. Cette approche est aujourd'hui dominante en psychologie expérimentale et constitue le socle des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), largement utilisées en clinique.

2.4 L'approche humaniste

Portée notamment par Carl Rogers et Abraham Maslow, la psychologie humaniste met l'accent sur le potentiel de développement personnel, l'autonomie et la recherche de sens de l'individu, plutôt que sur les déterminismes biologiques ou environnementaux. La célèbre pyramide des besoins de Maslow, bien que critiquée pour son manque de validation empirique rigoureuse, reste une référence largement enseignée.

2.5 L'approche biologique et les neurosciences cognitives

Portée par les progrès de l'imagerie cérébrale (IRM fonctionnelle, électroencéphalographie) depuis les années 1990, l'approche biologique cherche à établir les correspondances entre processus psychologiques et activité du système nerveux. Elle a permis des avancées majeures dans la compréhension des bases neuronales de la mémoire, du langage ou des émotions, ainsi que dans l'identification de facteurs de vulnérabilité biologique associés à certains troubles mentaux. Cette approche ne s'oppose pas aux précédentes mais les complète, la plupart des chercheurs contemporains adoptant aujourd'hui une perspective dite biopsychosociale, qui considère qu'un phénomène psychologique résulte toujours de l'interaction entre facteurs biologiques, psychologiques et sociaux.

3. Les processus psychologiques fondamentaux

3.1 La cognition

La cognition regroupe l'ensemble des processus mentaux impliqués dans l'acquisition, le traitement et l'utilisation de l'information : perception, attention, mémoire, langage et raisonnement. La mémoire, par exemple, n'est pas un système unique mais se décompose en plusieurs sous-systèmes (mémoire sensorielle, mémoire de travail, mémoire à long terme), chacun ayant ses propres caractéristiques et limites.

3.2 L'émotion

Les émotions sont des réponses psychophysiologiques complexes à des stimuli internes ou externes, impliquant des composantes subjectives (le ressenti), physiologiques (activation du système nerveux autonome) et comportementales (expression faciale, action). Les théories contemporaines s'accordent généralement sur l'existence d'émotions dites de base (peur, colère, joie, tristesse, dégoût, surprise), reconnaissables à travers les cultures, bien que leur expression et leur régulation restent fortement influencées par le contexte social.

3.3 Le comportement social

L'être humain est un être fondamentalement social : ses comportements sont constamment influencés par la présence, réelle ou imaginée, d'autrui. La psychologie sociale étudie des phénomènes comme la conformité, l'obéissance à l'autorité, les biais de perception d'autrui ou encore la formation des attitudes et des préjugés — des mécanismes qui jouent un rôle central dans la compréhension du

fonctionnement des groupes et des organisations.

4. Le développement psychologique de l'individu

Le développement psychologique désigne l'ensemble des transformations cognitives, affectives et sociales qui surviennent tout au long de la vie. Jean Piaget a proposé une théorie influente du développement cognitif de l'enfant, structurée en quatre stades (sensori-moteur, préopératoire, opérations concrètes, opérations formelles), chacun correspondant à une manière qualitativement différente d'appréhender le monde.

Erik Erikson, quant à lui, a proposé une théorie du développement psychosocial couvrant l'ensemble de la vie humaine, de la naissance à la vieillesse, organisée autour de huit crises ou conflits à résoudre à chaque étape (par exemple, confiance contre méfiance durant la première année de vie, ou identité contre confusion des rôles à l'adolescence). Ces modèles, bien que datés et parfois révisés à la lumière des connaissances actuelles, demeurent des repères pédagogiques largement enseignés.

Le développement de l'attachement, décrit notamment par John Bowlby, constitue également un champ d'étude majeur : la qualité du lien précoce entre l'enfant et sa figure d'attachement principale influence durablement sa capacité à réguler ses émotions et à construire des relations satisfaisantes à l'âge adulte.

5. La personnalité humaine

La personnalité désigne l'ensemble relativement stable des pensées, émotions et comportements qui caractérisent un individu et le distinguent des autres. Le modèle des Big Five (ou modèle en cinq facteurs) est aujourd'hui le cadre le plus largement validé empiriquement pour décrire la personnalité : ouverture à l'expérience, conscienciosité, extraversion, agréabilité et névrosisme (stabilité émotionnelle).

Ce modèle dimensionnel se distingue des typologies plus anciennes, comme les types psychologiques proposés par Carl Jung, en ce qu'il ne classe pas les individus dans des catégories fixes mais les situe sur des continuums. Il est aujourd'hui utilisé aussi bien en recherche fondamentale qu'en contexte appliqué (recrutement, orientation professionnelle), bien que son usage dans ces derniers contextes fasse l'objet de débats méthodologiques et éthiques.

6. Introduction à la psychopathologie

La psychopathologie est l'étude scientifique des troubles mentaux : leur description clinique, leurs causes possibles, leur évolution et leur traitement. Un trouble psychologique se définit généralement par la présence d'une souffrance significative ou d'une altération du fonctionnement (social, professionnel, personnel), qui dépasse les variations normales de l'humeur, de la pensée ou du comportement.

Les classifications diagnostiques de référence, notamment le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par l'association américaine de psychiatrie) et la CIM-11 (Classification internationale des maladies, publiée par l'Organisation mondiale de la santé), fournissent des critères standardisés permettant d'harmoniser le diagnostic entre cliniciens. Ces classifications évoluent avec les avancées de la recherche et font elles-mêmes l'objet de débats scientifiques, notamment sur la pertinence de catégories strictes par rapport à une approche plus dimensionnelle des troubles.

Note : les pathologies décrites dans les sections suivantes le sont à titre informatif et général. Elles ne permettent en aucun cas d'établir un diagnostic personnel. Seul un professionnel de santé qualifié (médecin, psychiatre, psychologue clinicien) est habilité à poser un diagnostic et à proposer une prise en charge adaptée.

7. Les troubles anxieux

Les troubles anxieux constituent l'une des catégories de troubles mentaux les plus fréquentes. Ils se caractérisent par une peur ou une anxiété excessive et persistante, disproportionnée par rapport à la situation réelle, et suffisamment intense pour perturber le fonctionnement quotidien.

7.1 Le trouble anxieux généralisé (TAG)

Il se manifeste par une inquiétude excessive et difficilement contrôlable, concernant de multiples domaines de la vie (travail, santé, relations), présente la plupart du temps pendant au moins six mois, et associée à des symptômes physiques comme la tension musculaire, la fatigue ou des troubles du sommeil.

7.2 Le trouble panique

Il se caractérise par des attaques de panique récurrentes et inattendues — des épisodes brefs et intenses de peur intense accompagnés de symptômes physiques marqués (palpitations, sensation d'étouffement, vertiges) — suivies d'une crainte persistante de nouvelles attaques, pouvant conduire à des comportements d'évitement.

7.3 Les phobies spécifiques et le trouble anxieux social

Les phobies spécifiques correspondent à une peur intense et irrationnelle déclenchée par un objet ou une situation précise (animaux, hauteur, avion). Le trouble anxieux social, quant à lui, se caractérise par une peur marquée des situations sociales dans lesquelles la personne craint d'être jugée, observée ou humiliée, ce qui peut conduire à un évitement significatif de ces situations.

7.4 Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC)

Longtemps classé parmi les troubles anxieux, le TOC constitue désormais une catégorie diagnostique distincte dans les classifications récentes. Il associe des obsessions — pensées, images ou impulsions

intrusives et récurrentes, source d'anxiété importante — et des compulsions, c'est-à-dire des comportements répétitifs (vérifications, lavages, rangements) ou des actes mentaux (compter, répéter des mots) que la personne se sent poussée à accomplir pour réduire l'anxiété liée aux obsessions, bien que le soulagement obtenu soit généralement temporaire. Le TOC peut avoir un retentissement majeur sur le fonctionnement quotidien lorsque les rituels occupent une part importante du temps de la personne.

8. Les troubles de l'humeur

8.1 La dépression (trouble dépressif caractérisé)

La dépression se caractérise par une humeur triste persistante et/ou une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités habituelles, pendant une durée d'au moins deux semaines, accompagnée de symptômes tels que des troubles du sommeil ou de l'appétit, une fatigue importante, des difficultés de concentration, des sentiments de dévalorisation ou de culpabilité excessive, et, dans les formes les plus sévères, des pensées de mort ou suicidaires. Elle figure parmi les principales causes mondiales d'incapacité selon l'Organisation mondiale de la santé, laquelle estime qu'elle touche plus de 280 millions de personnes dans le monde, tous âges confondus, avec une prévalence globalement plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

8.2 Le trouble bipolaire

Le trouble bipolaire se caractérise par l'alternance d'épisodes dépressifs et d'épisodes maniaques ou hypomaniaques. Un épisode maniaque se manifeste par une humeur anormalement élevée, expansive ou irritable, associée à une augmentation de l'énergie, une diminution du besoin de sommeil, une accélération du discours et, parfois, des comportements à risque ou impulsifs. La distinction entre trouble bipolaire de type I (épisodes maniaques complets) et de type II (épisodes hypomaniaques, moins sévères) est cliniquement importante pour orienter la prise en charge.

Si vous ou une personne de votre entourage traversez une période de détresse importante ou avez des pensées suicidaires, il est essentiel de solliciter rapidement l'aide d'un professionnel de santé ou d'un service d'écoute dédié. Ce document a une vocation strictement informative et ne remplace en aucun cas un accompagnement professionnel.

9. Les troubles de la personnalité

Un trouble de la personnalité se caractérise par un mode durable de fonctionnement et de comportement qui s'écarte de manière significative des attentes de l'environnement socioculturel de l'individu, se manifeste dans au moins deux des domaines suivants (cognition, affectivité, fonctionnement interpersonnel, contrôle des impulsions), et débute généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte.

9.1 Le trouble de la personnalité borderline (état-limite)

Il se caractérise par une instabilité marquée des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects, ainsi qu'une impulsivité significative. Les personnes concernées peuvent présenter une peur intense de l'abandon, des relations alternant entre idéalisation et dévalorisation de l'autre, et des comportements autodestructeurs dans les périodes de crise. Ce trouble reste l'un des plus étudiés et des mieux pris en charge par des approches thérapeutiques spécifiquement développées, comme la thérapie comportementale dialectique.

9.2 Le trouble de la personnalité antisociale

Il se caractérise par un mépris et une transgression persistante des droits d'autrui, se manifestant dès l'âge de 15 ans, incluant des comportements tels que la tromperie répétée, l'impulsivité, l'irritabilité, l'irresponsabilité et l'absence de remords face au tort causé à autrui.

9.3 Le trouble de la personnalité évitante

Il se caractérise par une inhibition sociale marquée, un sentiment de ne pas être à la hauteur et une hypersensibilité au jugement négatif d'autrui, conduisant la personne à éviter les activités impliquant des contacts sociaux importants par crainte d'être critiquée, rejetée ou désapprouvée. Ce trouble se distingue du trouble anxieux social par sa nature plus globale et durable, affectant l'ensemble du fonctionnement interpersonnel plutôt que des situations sociales circonscrites.

10. Les troubles psychotiques

Les troubles psychotiques se caractérisent par une altération du contact avec la réalité, se manifestant principalement par des hallucinations (perceptions sans objet réel, le plus souvent auditives) et des idées délirantes (croyances fermement maintenues malgré des preuves contraires évidentes).

10.1 La schizophrénie

La schizophrénie est le trouble psychotique le plus étudié. Elle associe des symptômes dits positifs (hallucinations, délires, désorganisation du discours), des symptômes négatifs (retrait social, émoussement des affects, perte de motivation) et, fréquemment, des altérations cognitives (attention, mémoire de travail). Son évolution est très variable d'une personne à l'autre, et une prise en charge précoce et adaptée améliore significativement le pronostic à long terme. Sa prévalence est estimée à environ 1 % de la population mondiale, sans différence marquée entre les sexes, bien que l'âge d'apparition soit généralement plus précoce chez les hommes (fin de l'adolescence-début de l'âge adulte) que chez les femmes.

10.2 Le trouble délirant

Il se caractérise par la présence d'une ou plusieurs idées délirantes persistantes pendant au moins un mois, en l'absence des autres symptômes caractéristiques de la schizophrénie, et avec un fonctionnement par ailleurs relativement préservé en dehors de la thématique délirante elle-même.

10 bis. Autres catégories de troubles fréquemment étudiées

Les troubles neurodéveloppementaux

Les troubles neurodéveloppementaux apparaissent précocement dans le développement de l'enfant et affectent le fonctionnement personnel, social ou scolaire. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) se caractérise par des difficultés d'attention, une impulsivité et, selon les cas, une hyperactivité motrice inadaptées au niveau de développement de l'enfant. Les troubles du spectre de l'autisme (TSA) se caractérisent par des difficultés persistantes de communication et d'interaction sociale, associées à des comportements, intérêts ou activités restreints et répétitifs, avec un degré de sévérité et une présentation clinique très variables d'une personne à l'autre — d'où l'usage du terme de « spectre ».

Les troubles du comportement alimentaire

Les troubles du comportement alimentaire se caractérisent par une perturbation persistante de l'alimentation ou de comportements liés à l'alimentation, entraînant une altération significative de la santé physique ou du fonctionnement psychosocial. L'anorexie mentale associe une restriction alimentaire conduisant à un poids significativement bas, une peur intense de prendre du poids et une perturbation de la perception du corps. La boulimie se caractérise par des épisodes récurrents de prise alimentaire excessive suivis de comportements compensatoires inappropriés (vomissements provoqués, usage de laxatifs, exercice physique excessif). Ces troubles comptent parmi les troubles psychiatriques associés au risque de complications médicales les plus élevés, ce qui justifie une prise en charge pluridisciplinaire précoce, associant suivi médical, nutritionnel et psychothérapeutique.

11. Approches thérapeutiques et prise en charge

La prise en charge des troubles psychologiques repose généralement sur une combinaison d'approches selon la nature et la sévérité du trouble : psychothérapies (thérapies cognitivo-comportementales, psychodynamiques, humanistes, systémiques), traitements pharmacologiques (antidépresseurs, anxiolytiques, stabilisateurs de l'humeur, antipsychotiques selon les cas), et interventions psychosociales (soutien à la réinsertion, psychoéducation des familles).

Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) comptent parmi les approches les plus documentées empiriquement, notamment pour les troubles anxieux et la dépression. Elles reposent sur l'identification et la modification des pensées et comportements dysfonctionnels qui entretiennent la souffrance psychologique.

Il est important de souligner qu'aucune approche n'est universellement supérieure aux autres : l'efficacité d'un traitement dépend fortement du trouble concerné, de la sévérité des symptômes, des préférences de la personne et de la qualité de l'alliance thérapeutique établie avec le professionnel accompagnant.

12. Facteurs de risque et facteurs de protection

La recherche en psychopathologie s'accorde aujourd'hui sur un modèle explicatif dit de vulnérabilité-stress : un trouble mental se développe généralement à l'intersection d'une vulnérabilité préexistante (génétique, biologique ou liée à des expériences précoces) et d'un ou plusieurs facteurs de stress environnementaux (événements de vie difficiles, isolement social, précarité). Aucun trouble mental ne résulte donc d'une cause unique et isolée.

Parmi les facteurs de risque les plus documentés figurent les antécédents familiaux de troubles psychologiques, l'exposition à des événements traumatiques (notamment durant l'enfance), l'isolement social et certaines conditions socio-économiques défavorables. À l'inverse, plusieurs facteurs de protection ont été identifiés : un réseau de soutien social de qualité, des stratégies d'adaptation (« coping ») efficaces face au stress, un accès rapide à des soins appropriés, ainsi qu'un sentiment de contrôle et d'efficacité personnelle face aux difficultés rencontrées.

Cette compréhension multifactorielle a des implications importantes pour la prévention : plutôt que de chercher une cause unique à un trouble donné, les politiques de santé publique contemporaines cherchent généralement à renforcer les facteurs de protection à l'échelle des populations (éducation émotionnelle dès le plus jeune âge, lutte contre l'isolement social, accès facilité aux soins de santé mentale) tout en réduisant l'exposition aux facteurs de risque identifiés.

13. Conclusion

La psychologie humaine, dans sa dimension fondamentale comme dans sa dimension clinique, constitue un champ de connaissance vaste et en constante évolution. La compréhension des processus psychologiques normaux (cognition, émotion, développement, personnalité) est indissociable de celle des pathologies qui peuvent en affecter le fonctionnement. Les avancées continues de la recherche, combinant approches cliniques, neuroscientifiques et sociales, permettent d'affiner progressivement à la fois les classifications diagnostiques et les prises en charge proposées aux personnes concernées.

Ce document ne constitue qu'une introduction générale : chacun des sujets abordés fait l'objet d'une littérature scientifique considérable, et toute question relative à une situation personnelle ou à celle d'un proche doit être adressée à un professionnel de santé qualifié.

Enfin, il convient de rappeler qu'un trouble mental ne définit jamais entièrement la personne qui en est atteinte. La déstigmatisation des pathologies psychologiques, encouragée par de nombreuses organisations de santé publique à travers le monde, constitue un enjeu majeur pour favoriser le recours précoce aux soins et améliorer la qualité de vie des personnes concernées comme celle de leur entourage.

Sources et références générales

American Psychiatric Association — Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5).

Organisation mondiale de la santé — Classification internationale des maladies, 11e révision (CIM-11).

Organisation mondiale de la santé — Rapports sur la santé mentale et la dépression dans le monde.

Ouvrages généraux de référence en psychologie du développement, psychologie sociale et psychopathologie utilisés dans l'enseignement universitaire francophone.